

신장기능 eGFR·단백뇨 결과 안내

eGFR은 혈액검사로 추정된 콩팥 여과 능력, 단백뇨·알부민뇨는 소변으로 단백질이 새는 정도를 봅니다. 한 번의 이상만으로 만성콩팥병을 확정하지 않고, 반복 확인과 위험도 평가가 필요합니다.



수치가 뜻하는 것

EGFR

≥90

정상 범위

EGFR

60~89

다른 이상 동반 시 추적

EGFR

<60

3개월 이상이면 CKD

UACR

≥30

mg/g 추적

왜 재검이 필요한가요?

일시적으로 나빠질 수 있는 경우

탈수·금식 — 크레아티닌 상승, 소변 농축
격한 운동 — 일시적 혈뇨·단백뇨 가능
감기·발열·요로감염 — 소변 이상 동반 가능
진통소염제 — NSAID 복용 시 신장 부담 증가
크레아틴 보충제 — 크레아티닌이 올라 eGFR이 가짜 저하로 나올 수 있음

다음 확인 검사

크레아티닌/eGFR 재검 — 대개 1~3개월 간격
uACR — 거품 모양이 아닌 검사로 단백뇨 확인, 미세알부민뇨 평가에도 유용
혈압·당뇨 평가 — 콩팥 손상의 가장 흔한 원인
소변 침사·초음파 — 혈뇨, 결석, 구조 이상 확인
소변검사 준비 — 소변이 진하면 단백뇨처럼 보일 수 있어(가짜 단백뇨), 소변검사만 있는 날은 평소처럼 물을 드세요

콩팥을 지키는 생활 원칙

줄일 것

짠 음식 — 국물·젓갈·가공식품 줄이기
진통소염제 남용 — 이부프로펜·나프록센 등 상담 후
고단백 보충제 — eGFR 저하 시 무리한 섭취 피하기
흡연 — 혈관·콩팥 기능 악화와 연관

관리할 것

혈압 목표 확인 — 가정혈압 기록이 도움
혈당 관리 — 당뇨가 있으면 HbA1c와 uACR 추적
수분 균형 — 탈수 피하되 심부전·부종은 별도 상담
정기 추적 — eGFR 변화 속도와 단백뇨가 핵심
칼륨 공포 — 신장수치가 조금 낮다고 과일·채소를 무조건 끊을 필요는 없음, 혈중 칼륨 수치로 판단

빨리 진료가 필요한 신호

소변량이 갑자기 줄거나, 전신 부종이 생기거나, 육안적 혈뇨·요구리 통증·고열이 있으면 빨리 진료를 보세요. 소변이 거의 나오지 않거나 숨이 차면 응급실로 가세요. eGFR이 30 미만, 단백뇨가 심함, 혈뇨와 단백뇨가 함께 지속되는 경우에는 전문 진료가 필요할 수 있습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — KDIGO 2024 CKD Guideline · KDIGO Potassium Controversies Conference(2020) · National Kidney Foundation eGFR/ACR 안내

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 추적 간격과 약을 조절은 원인, 혈압·당뇨, 이전 수치 변화에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/egfr-proteinuria/

